内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肠易激综合征

（性感认识：功能性疾病）

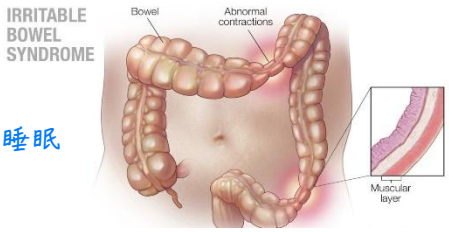
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、发病机制

脑-肠轴

内脏高敏感性（核心）、胃肠动力异常、肠道免疫激活（感染等引起）、肠道微生态失衡、精神心理障碍等共同作用引起肠-脑互动异常（你敏感肠道跟着你敏感、你紧张肠道跟着你紧张）

精神因素可以是急性胃炎的病因、肠易激综合征的病因、十二指肠溃疡的诱因



二、临床表现

1.青壮年多见，慢性病程　肠道发生痉挛

①腹痛部位不定，多为下腹和左下腹痛，**极少在睡眠中痛醒** 疼痛不足以影响睡眠

可能因神经心理障碍导致睡眠差，因此睡眠差不能排除肠易激综合征

②粪便**可有黏液、但绝无脓血**

③排便不净感，排便排气后可缓解

④多无明显体征

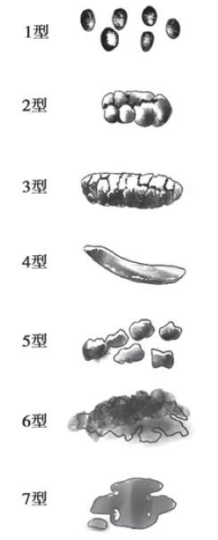


图 4-10-1　粪便性状量表

2.分型

①便秘型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＜1/4 的排便为 6 或 7 型

②腹泻型：＞1/4 的排便为 6 或 7 型、且＜1/4 的排便为 1 或 2 型

③混合型：＞1/4 的排便为 1 或 2 型、且＞1/4 的排便为 6 或 7 型

④不定型

一般：消化系统疾病腹泻出现体重↓无特异性

特殊：肠易激综合征腹泻，体重却无明显变化

可能可能最可能：粪便**可有黏液但绝无脓血**、**焦虑**等使症状加重、体重**无**明显变化

功能性疾病

三、诊断标准

①反复发作的腹痛、腹胀和腹部不适与排便相关，伴粪便性状和/或排便频率改变

②症状至少 6 个月、近 3 个月症状符合诊断标准

③常规检查包括**结肠镜未发现**可解释症状的器质性、系统性、代谢性疾病的证据

四、治疗　区别于维拉帕米、硝苯地平，匹维溴铵用于消化道

解痉止痛 （尔嗅俺丁）	①肠道平滑肌解痉剂：**匹维溴铵**、奥替溴铵、**曲美布汀**、阿尔维林 ②抗胆碱药（短期用）　属于CCB，平滑肌收缩需要Ca^{2+}→现在被拮抗了→解痉
止泻 （luo nuo tuo tan）	①阿片受体激动剂：**洛哌丁胺**、地芬诺酯　吗啡可以止泻 ②吸附剂：**蒙脱石散**、药用炭
缓解便秘 （秒变蠢驴）	①渗透性泻剂：**聚乙二醇**　开塞露 ②促分泌剂：鸟苷酸环化酶激动剂、Cl^-通道激动剂
调节内脏感觉 前三组无效才选	①鸟苷酸环化酶激动剂 ②神经递质调节剂：5-HT 再摄取抑制剂、**三环类抗抑郁药阿米替林**　抑制了突触前膜再摄取递质 VS 利血平：抑制囊泡再摄取递质
调节肠道炎症和菌群失调	①肠道不吸收的**抗生素**：**利福昔明**（短期用） ②**益生菌**：双歧杆菌、乳酸杆菌